

NMX-42

Explorador Renal de Alimentos y Equivalentes

Fase	Fase 5 · Clínica
Categoría	Explorador dietético renal
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Incluye hoja VALIDACION_RENAL oculta.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-42_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-42 · Explorador Renal de Alimentos y Equivalentes
Fase	Fase 5 · Clínica
Categoría	Explorador dietético renal
Público	Docente; Nutricionista (apoyo clínico profesional); Estudiante de Nutrición y Dietética (avanzado)
Objetivo	Explorar y filtrar alimentos por criterios renales y proponer sustituciones/intercambios en equivalentes, dentro de un marco de distribución autorizada y revisión clínica.
Entradas principales	Clínica: Límites/metas renales del paciente; Selecciones / listas desplegables: Filtros y criterios renales, Alimento a sustituir
Resultados principales	Alimentos filtrados; Sustituciones/intercambios
Nivel sugerido	Educativo / apoyo clínico profesional
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros (declarado). Incluye hoja VALIDACION_RENAL oculta.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-42 es un explorador renal de alimentos y equivalentes: sobre la base INTA 2018 clasificada permite buscar y filtrar alimentos según criterios renales y proponer sustituciones e intercambios. La distribución está autorizada por el titular; el libro conserva su estado 'sujeto a revisión clínica'. Comparte enfoque renal con NMX-22/29. Pertenece a la Fase 5.

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Explorar y filtrar alimentos por criterios renales y proponer sustituciones/intercambios en equivalentes, dentro de un marco de distribución autorizada y revisión clínica.

Objetivos específicos

- Definir paciente y límites renales.
- Buscar y filtrar alimentos en la base clasificada.
- Proponer sustituciones e intercambios renales.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Docente
- Nutricionista (apoyo clínico profesional)
- Estudiante de Nutrición y Dietética (avanzado)

Población de referencia (según el libro)

Contexto renal; base INTA 2018 clasificada; distribución autorizada, sujeto a revisión clínica.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Buscar y filtrar	Filtra alimentos por criterio renal	Filtros renales	Lista filtrada	Intermedio
Sustitución	Propone alimentos alternativos	Alimento + criterio	Sustituciones	Intermedio
Intercambios en equivalentes	Ofrece intercambios renales	Equivalentes	Intercambios	Intermedio

06 VARIABLES DE ENTRADA

Clínica

Límites/metas renales del paciente

Selecciones / listas desplegables

Filtros y criterios renales, Alimento a sustituir

NUTRIMETRÍA · NMX-42

Paciente y límites indicados

☐ VOLVER A INICIO

IDENTIFICACIÓN

Nombre o identificador

Caso de ejemplo

Edad (años)

58

Situación renal

Trasplante

Peso de cálculo (kg)

68

Fecha

2028-07-24

Profesional responsable

—

Diabetes (confirmación clínica)

ND

LÍMITES DIARIOS INDICADOS POR EL EQUIPO TRATANTE

Meta clínica de potasio (mg/día)

2500

Meta clínica de fósforo (mg/día)

900

Meta clínica de sodio (mg/día)

2000

Meta clínica de proteínas (g/día)

ND

Meta clínica de energía (kcal/día)

2040

Debe provenir de la indicación clínica, no de este libro

Ajustar según fosemia

Límite máximo

1.2 g/kg en diálisis

30 kcal/kg

Estas metas son registradas por el profesional y no se derivan de una tabla universal. Potasio, fósforo y sodio dependen del contexto clínico; proteína debe diferenciar no diálisis.

PRIORIDAD DE ESTA CONSULTA

Nutriente que se quiere reducir

Potasio

Laboratorio reciente · potasio sérico

5,8

Laboratorio reciente · fósforo sérico

5,4

Observaciones clínicas

Hiperkalemia persistente pese a la restricción declarada.

Determina el orden en que el sustituidor propone alternativas

Los límites diarios NO los define este libro: los define el equipo tratante a partir del laboratorio y de la situación del paciente. Aquí solo se registran para que el explorador ordene los alimentos según esa indicación.

Potasio

NUMERICO_INGRESADO

Equipo tratante

No existe cifra universal. Integrar kalemia, fármacos, acidosis, diálisis.

Fósforo

NUMERICO_INGRESADO

Equipo tratante

No existe cifra universal. INTA no captura bien aditivos fosfatados ni

Sodio

NUMERICO_INGRESADO

Equipo tratante / KDOQI 2020

KDOQI orienta <2300 mg/día en ERC 3–5, SD o postrasplante;

Proteínas

ND

Equipo tratante / KDOQI 2020

No usar una cifra para todas las poblaciones. Trasplante requiere

Energía

NUMERICO_INGRESADO

Equipo tratante / KDOQI 2020

25–35 kcal/kg/día es un rango orientador sujeto a edad, actividad,

NUMERICO_INGRESADO indica una meta clínica documentada. ND indica ausencia de un dato utilizable; ND nunca equivale a cero y no permite declarar un alimento seguro.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Alimentos filtrados	COMPARACIÓN	lista	Depende del filtro

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
EXPLORADOR	RESULTADOS
SUSTITUCION	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA - NMX-42	
Fuente, método y advertencias clínicas	
VOLVER A INICIO	
FUENTE Y MÉTODO	Detalle
Composición de alimentos	Tabla de Composición de Alimentos del INIA, Universidad de Chile, edición 2018. Valores por cien gramos de porción comestible. Se aplicó la reconstrucción del grupo E 10 de vendajes y frotabajas, cuya lista de subítemos no viene en el archivo fuente, cada registro completo queda marcado en la columna correspondiente.
Licencia	BLDG080 ACTIVO. No se encontró autorización de redistribución comercial dentro del material entregado. Los personal del libro, no redistribuir, no comercializar y no incorporar a un producto de pago sin autorización documentada. Nutrimetría no cuenta con respaldo del INIA ni de la Universidad de Chile. Esta revisión no sufre de sesgo público.
Cobertura de los nutrientes críticos	Potasio presente en 603 de 618 alimentos, sodio en 608 y calcio en 587. Solo 37% alimentos tienen los cinco nutrientes críticos completos y pueden usarse en este explorador. Los 242 restantes quedan excluidos porque se desconoce su contenido, NO porque sean inadecuados.
Un dato ausente no es un error	Es el principio que ordena todo este libro. Un alimento sin dato de potasio no puede recomendarse como bajo en potasio. Si el paciente lo consume, ese carga no aparece en ningún total y el cálculo queda subestimado sin que nadie lo advierta, salvo la marca de no utilizables.
Unidades de clasificación	Los datos de contenido bajo, medio, alto y muy alto son convenciones de trabajo de este libro para CHEDENAR alimentos. No existen categorías normales por cien gramos, lo que importa críticamente es la carga total del día frente al laboratorio del paciente. Son editables en CONFIG.
Reservar espacio sobre proteínas	Explica los riesgos de los datos por gramos de proteína del alimento. Es el criterio habitual para elegir fuentes proteicas en enfermedad renal, porque permite cubrir el requerimiento de proteína con la menor carga hidrolítica posible. Solo se calcula en alimentos que aporten al menos el mínimo de proteína configurado: aplicado a una fracción a una unidad de proteína eficaz en su totalidad.
Factores de ajuste - Interacción mayor	Las tablas de composición reflejan el factor natural del alimento y NO el añadido como aditivo en productos procesados, embotellados, bebidas de venta y quesos fundidos. El factor incorporado de los aditivos tiene abstracción casi completa, de modo que la carga real puede superar ampliamente lo que muestra este explorador. Revisar siempre el etiquetado.
Calcular y potasio	El tiempo prolongado y la doble acción reducen el contenido de potasio de algunos alimentos, en proporciones que la fuente no documenta. Este libro NO aplica factores de reducción: muestra el alimento tal como figura en la tabla. Sustituir el alimento no es la única vía para bajar la carga de potasio.
Sustituir de sal	No hay que en la base y su valor estar formulado con datos de potasio. Se usa para descomponer la química de la sal y solo se descompone la química de la sal, como hace el módulo NMX-28.
Intercambios reales	Un intercambio renal debe verificarse en potasio, sodio y calcio a la vez. Un alimento intercambiable por macronutrientes puede no serlo en contenido renal, y un alimento bajo en potasio puede ser muy alto en sodio.
Relación con otros módulos	NMX-22 registra la ingesta renal de varios días. NMX-28 busca el recordatorio renal con sondas de fuentes ocultas. Este módulo se ocupa de la selección de alimentos: qué elegir y por qué cambiar uno por otro.
Que NO hace este libro	No prescribe límites. No define el equipo terapéutico. No diagnostica. No calcula la ingesta de un paciente. No considera aditivos, excepto en sustitutos de sal. No está validado clínicamente.
KIDOP 2020 - KIDOP 2024 - Trazabilidad Clínica	
KIDOP 2020	Evaluación y manejo nutricional: problema diferenciado, energía individualizada y electrolitos según contexto.
Fuente oficial KIDOP	https://www.kidop.org/pressroom/2020/04/01/comunicado-2020-04-01
DOI KIDOP	https://doi.org/10.1002/ajkd.2020.05.008
KIDOP 2024	Evaluación y manejo de RRC: CAG, TPO, ACR, comorbilidades, riesgo y demarcado.
Fuente oficial KIDOP	https://kidop.org/pressroom/2024/04/01/comunicado-2024-04-01
PDF KIDOP 2024	https://kidop.org/pressroom/2024/04/01/comunicado-2024-04-01.pdf
KIDOP 2024	Actualización fundamentada en desarrollo de DESARROLLO, NO IMPLEMENTAR.
Fuente oficial KIDOP	https://kidop.org/pressroom/2024/04/01/comunicado-2024-04-01
Manejo sistemático	NMX puede representar formulaciones personalizadas actuales, mejorar equipos, monitoreo y verificación.
Datos de	Se conservan como NO, nunca como cero, los datos pueden sustituir la carga real.

Figura 3. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 14 hojas (13 visibles y 1 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 367 fórmulas, 1 gráficos, 0 tablas estructuradas y 9 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Paciente ficticio con límites renales definidos.
Proceso	Se filtran alimentos según los criterios renales.
Resultado	El explorador propone sustituciones e intercambios.
Interpretación educativa	El profesional valida las alternativas antes de usarlas.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

FLUJO DE USO	
1	Lea LICENCIA y complete la lista de revisión clínica. Sin eso, el libro se declara no apto.
2	En DATOS registre al paciente y los límites diarios INDICADOS por el equipo tratante, y elija qué nutriente quiere reducir.
3	En EXPLORADOR consulte alimentos y porciones: verá el contenido, el nivel de cada nutriente y qué proporción del límite diario aporta la selección.
4	En SUSTITUCIÓN indique un alimento a reemplazar y revise las alternativas del mismo grupo con menor carga.
5	En EQUIVALENTES revise cómo se distribuyen los alimentos utilizables entre los grupos renales.
6	En CONFIG ajuste los umbrales de clasificación al criterio que usted aplica.
7	Para registrar la ingesta del paciente use NMX-22 o NMX-29: este módulo selecciona alimentos, no evalúa consumo.

Figura 4. Vista inicial (hoja INICIO).

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	Clasificación renal de alimentos	Renal	Filtro y sustitución	Requiere revisión

REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	Reconstrucción del grupo 2.10 (verduras) marcada	Chile	Cobertura de base	Registros corregidos identificados
-------------------------	--	-------	-------------------	------------------------------------

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
INTA, Universidad de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Base clasificada	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Distribución autorizada por el titular; sujeto a revisión clínica. Herramienta de apoyo; la interpretación clínica es profesional.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Apoyo clínico profesional
- No reemplaza el juicio profesional
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-22 • Registro Nutricional para Enfermedad Renal
- NMX-29 • Recordatorio de 24 Horas Renal
- NMX-21 • Distribución Alimentaria (INTA 2018)

Versionado

Producto_ID	NMX-42
Archivo analizado	NMX-42_KDOQI_KDIGO(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-42 · Explorador Renal de Alimentos y Equivalentes

Fase 5 · Clínica · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.